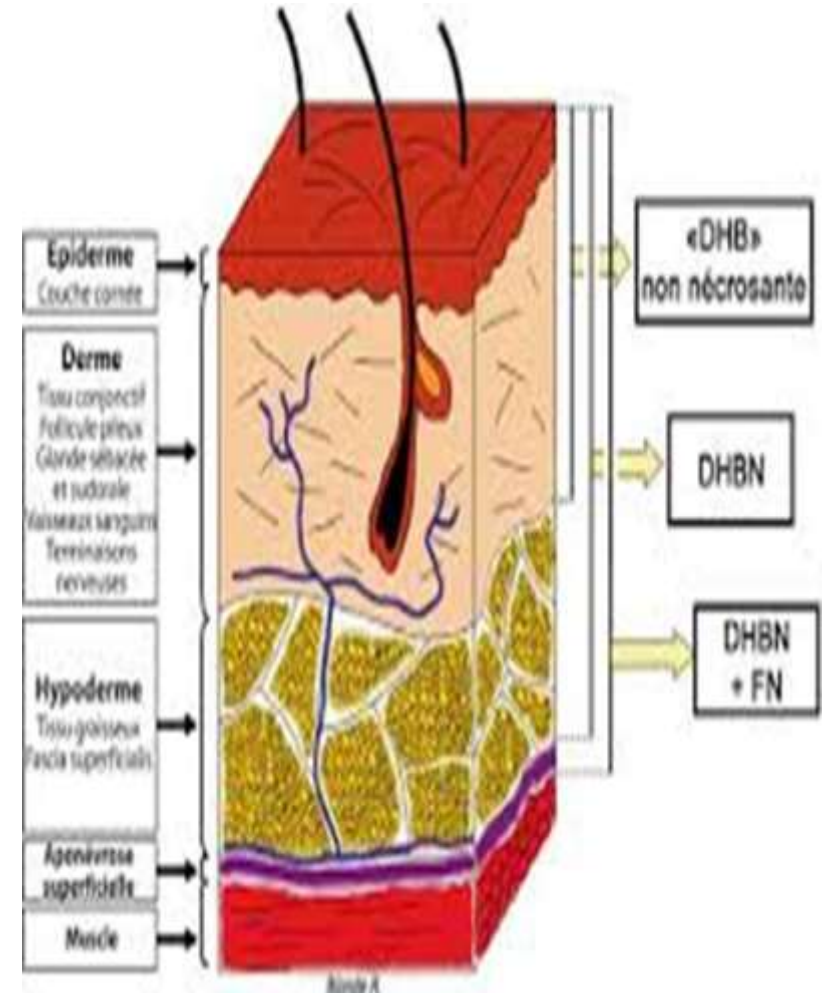


Dermohypodermites bactériennes nécrosantes et non nécrosantes

Module de Maladies Infectieuses
Quatrième Année de Médecine
Année Universitaire : 2025/2026

Pr. CHACHOU. B / Dr. FEITA. RK / Dr. BRAHIMI. RK



OBJECTIFS

- **Reconnaitre le diagnostique Dermohypodermite bactériennes nécrosantes et non nécrosantes.**
- **Planifier la prise en charge thérapeutique.**
- **Appliquer les mesures de prévention.**

Dermohypodermites bactériennes nécrosantes et non nécrosantes

- **Introduction**
- **Rappel anatomique et terminologique**

I/Dermohypodermite aiguë bactérienne non nécrosante : érysipèle

- A. Définition
- B. Epidémiologie
- C. Diagnostic positif
- D .Evolution
- E. Traitement

II/Dermohypodermites bactérienne nécrosantes

- A. Definition
- B. Epidemiologie
- C. Physiopathologie
- D. Diagnostic positif
- E. Formes cliniques
- F. Traitement :

INTRODUCTION

DÉFINITION

- Les dermohypodermites bactériennes nécrosantes (DHBN) et non nécrosantes (DHBNN) sont des **infections des parties molles, classées anatomiquement selon la profondeur de l'atteinte**
- Elles se caractérisent par une **inflammation aiguë à pyogène du derme profond et des tissus sous-cutanés.**
- La **DHBNN** est un **motif fréquent de consultation, forte morbidité** et d'un **coût de santé publique important.**
- L'**érysipèle** est une forme de DHBNN due au **streptocoque beta hémolytique du groupe A.**
- La **DHBN** est **rare, mais de gravité extrême, dont la létalité est plus de 30%.** Elle nécessite une prise en charge **médico-chirurgicale urgente.**
- La **précocité du diagnostic** et le traitement par une **antibiothérapie adaptée** améliore le pronostic.

RAPPEL ANATOMIQUE ET TERMINOLOGIQUE :

-La peau est constituée d'un **épiderme**, d'un **derme**, d'un **hypoderme**.

-L'**hypoderme** est limité dans sa partie profonde par le **fascia superficialis**, **mal individualisé** et **inconstant**, et une structure solide plus profonde, l'aponévrose superficielle, siège de la nécrose dans la fasciite .

-Un **fascia** est une **membrane fibreuse** qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique. C'est un tissu conjonctif dense, très riche en fibres de collagène, qui constitue une sorte de gaine.

-**Les fascias** sont différents des aponévroses (lames fibreuses appartenant en propre à un muscle dont elles constituent en quelque sorte un revêtement).

Épiderme :

- couche cornée,
- kératinocytes.

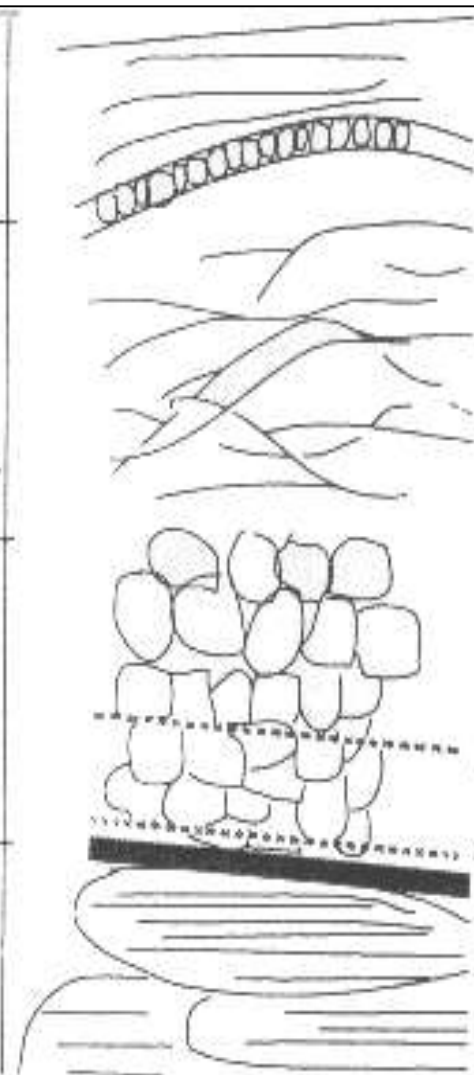
Derme :

- tissu conjonctif,
- follicules pileux,
- glandes sébacées et sudorales,
- terminaisons nerveuses,
- vaisseaux.

Hypoderme :

- tissus graisseux,
- vaisseaux.

Muscle



Dermohypodermite bactérienne

= DHB

= érysipèle :

sans atteinte de
l'aponévrose superficielle

= cellulitis en anglais

**ou Dermo-hypodermite
bactérienne nécrosante**

= DHBN :

avec nécrose du tissu conjonctif
et adipeux mais sans atteinte de
l'aponévrose superficielle
= necrotising cellulitis en anglais

Fascia superficialis
(inconstant)

Aponévrose
superficielle

Fasciite nécrosante = FN :

avec nécrose de
l'aponévrose superficielle
= necrotising fasciitis en anglais

Myosite

°La situation du fascia superficialis est variable : a - sous l'hypoderme, b - un peu plus haut.
Note : DHBN et FN sont fréquemment associées.

I/Dermohypodermite aiguë bactérienne non nécrosante : « érysipèle »

A. Définition

-L'**érysipèle** est une infection cutanée touchant **le derme et l'hypoderme**, **aigue, localisée, non nécrosante** d'origine bactérienne essentiellement due à **streptococcus pyogènes** (streptocoque beta hémolytique du groupe A).

B. Epidémiologie

1/Les modalités épidémiologiques :

*C'est une pathologie **commune**, souvent **traitée à domicile**.

*Elle est **rare chez l'enfant**, s'observe chez l'adulte **après 40ans**.

2/ les germes en cause :

****Streptococcus pyogènes*** essentiellement, plus rarement streptocoque β -hémolytique des groupes B, C et G.

***La sensibilité** de ces bactéries à la pénicilline est de **100 %**.

3/Localisation :

*Le plus souvent aux **membres inférieurs**.

***La face** est une localisation rare, mais possible: il forme une **plaque érythémateuse oedémateuse** inflammatoire de la face, bien limitée en **périphérie par un bourrelet**, parfois **bilatéral en aile de papillon**.

4/ les facteurs favorisants :

Des facteurs de risques ont été mis en évidence

→ **Locaux** : lymphoedème et porte d'entrée intertrigo inter-orteils, ulcère de jambe

→ **Généraux** : l'obésité.

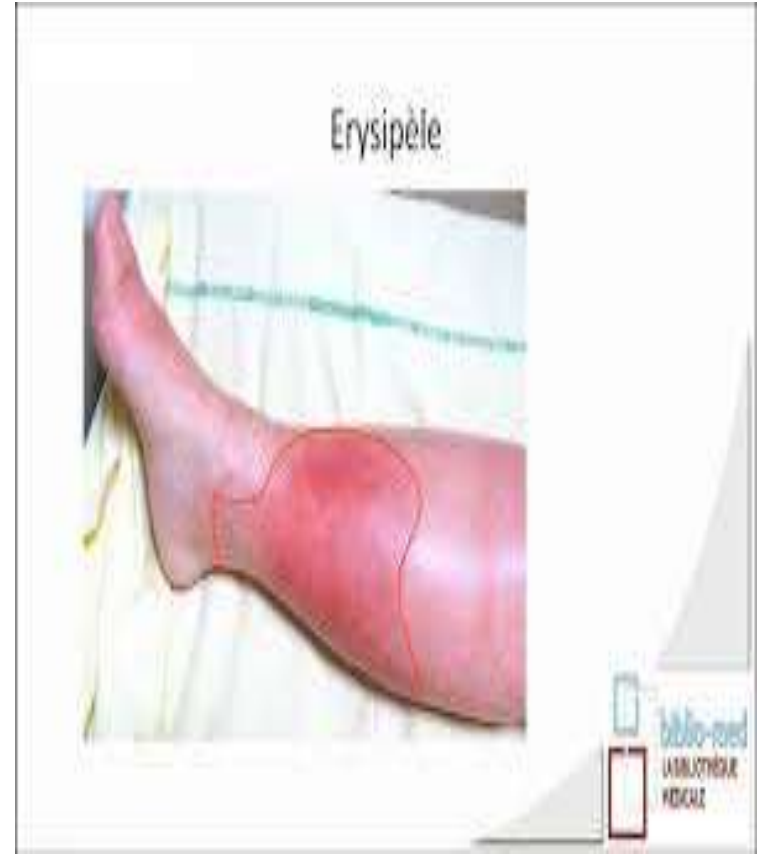


C.Diagnostic positif

1/Reconnaitre l'erysipèle

- * **La forme habituelle** : donne un tableau de « **grosse jambe rouge aigue fébrile** » **unilatérale**.
- * Le début est **brutal**, par une **fièvre** élevée (39 a 40°C) accompagnée de frissons, qui précède souvent de quelques heures l'apparition **du placard cutané inflammatoire**.
- * C'est une plaque **érythémateuse** , **œdémateuse**, **chaude**; **circonscrite et douloureuse a la palpation**.
- * Un **bourrelet périphérique** marque est rarement observe.
- * Dans certains cas, des bulles **superficiels**, ou un **purpura**, sont observes sur le placard.
- * **Des adénopathies** inflammatoires homolatérales **satellites** sont fréquemment associées.
- * **Une trainée de lymphangite** homolatérale parfois présent.
- * **Une porte d'entrée** est décelable cliniquement dans les deux tiers des cas. Elle peut être minime (**intertrigo inter orteils, piqure, érosion traumatique**) voire inapparente ou évidente (**ulcère de jambe**).

- Devant un tableau typique : **aucun examen complémentaire n'est nécessaire**.
- La recherche **d'une thrombose veineuse** s'impose au moindre doute par **echodoppler**.





Les examens complémentaires :

- Ils ne sont **pas nécessaires** dans un érysipèle typique.
- Dans les formes atypiques, ou avec atteinte de l'état général.
- NFS : une **hyperleucocytose** est habituelle avec **polynucléose neutrophile**.
- Le **syndrome inflammatoire** biologique est important (**CRP souvent >100mg/l**).
- Les **hémocultures** ne sont pas réalisées systématiquement en l'absence de signes de sepsis grave.
- Un **prélèvement bactériologique** de toute porte d'entrée, est utile dans les formes graves pour adapter l'antibiothérapie si nécessaire.

D. Traitement:

1. Antibiothérapie

1 iere intention : les betalactamines actives contre le **S.pyogenes**.

L'amoxicilline et la pénicilline G sont les ATB de référence.

-En cas d'hospitalisation le TRT est par **voie parentérale**

Posologie : amoxi 50 à 100 mg/kg/j.

Peni G 12 à 24 M UI/j.

-L'obtention de l'apyrexie permet le passage à la voie orale (amoxi 3 à 4 g /j en 3 prises quotidiennes) jusqu'à disparition des signes locaux.

La durée du TRT comprise **entre 10 et 20 jrs**.

-Devant un érysipèle typique **sans signes de gravité** un TRT **oral a domicile** est possible sous surveillance médicale.

- Les **alternatives thérapeutiques** aux β -lactamines, en cas d'allergie, sont les **synergistines (pristinamycine)**, Les **lincosamides (clindamycine)** ou les **glycopeptide**.

- Les **traitements adjuvants** : comprennent **le repos au lit** .
- un traitement **anticoagulant préventif** n'est associé qu'en cas de risque de **maladie thromboembolique**.
- Les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** ayant été accusés de favoriser l'évolution vers des formes graves sont **formellement contre-indiqués**.
- Un traitement symptomatique de la **douleur** sera prescrit.

→ **Indication d'hospitalisation**

- **Doute diagnostique**
- **Si un traitement parentéral** ou une **surveillance rapprochée** est nécessaire
- **Signes généraux** très marqués
- **Risques de complications** locales
- **Comorbidité**
- **Contexte social** rendant le suivi difficile en ambulatoire
- **Échec d'un traitement ambulatoire** préalable adapté et l' **absence d'amélioration après 72 H de TRT**

E.Evolution

→ **Est favorable en 8 à 10 jours** sous traitement ATB.

- dans la majorité des cas l'apyrexie est obtenue en **48 à 72 heures** elle précède l'amélioration des signes locaux qui est observée après plusieurs jours.

-Une phase d'extension dans les premières 24h sous traitement (érythème débordant les limites initiales dessinées au feutre) est fréquemment observée.

-Une phase de desquamation superficielle secondaire est parfois observée.

→ **défavorable** : cependant des complications peuvent se voir

1. **Locales** dans 5 à 10% des cas : **abcès localisés** superficiels, plus rarement profonds, qui doivent être incisés et drainés, parfois sous anesthésie générale.
2. **Systémiques**, très rares (<5% des cas): septicémie à streptocoque, glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique;
3. **Récidive**: c'est la complication la plus fréquente (environ 20—30% des cas); elle est en général la conséquence de la persistance des facteurs de risque: une porte d'entrée chronique (intertrigo inter orteil récidivant, ulcère de jambe). l'absence de prise en charge d'une insuffisance veineuse ou lymphatique associée.

→ **F. La prévention :**

- Elle est **primaire**, par :
 - Le traitement d'une **porte d'entrée** (notamment diagnostic et traitement d'un intertrigo interorteils),
 - **L'amélioration des troubles circulatoires** (port de bandes de contention, drainage lymphatique manuel),
 - **Une hygiène cutanée correcte ;**
- Dans les **formes récidivantes (02 épisodes par an)**:
 - La prise en charge de tout facteur favorisant .
 - Une antibioprophylaxie: au long cours dont l'intérêt devra être réévalué périodiquement
 - Benzathine-pénicilline G: 2,4MUI/2 à 4 semaine, en IM
 - Pénicilline V per os
 - Macrolide en cas d'allergie)

I/Dermohypodermite aiguë bactérienne nécrosante

A.Definition :

- Contrairement à l'érysipèle, **prolifération bactérienne est intense avec nécrose.**
- La nécrose **évolue de la profondeur** (hypoderme) **vers la superficie** :lésions profondes beaucoup **plus sévères** que ce qu'on peut visualiser à l'examen clinique.
- Urgence médico-chirurgicale.**

B.Epidemiologie :

1/Les modalités épidémiologiques :

- Une infection **Rare**, 100 fois moins fréquente que l'érysipèle
- Elle est **grave : 30 % de mortalité.**
- Responsables de **séquelles trophiques** importantes pour les survivants.

2/ les germes en cause :

-**S.pyogenes** est l'agent causal **le plus fréquent**.

-Il est fréquemment **associé a d'autres bactéries** (Le staphylocoque doré, des bacilles Gram-négatifs, des anaérobies)

3/Localisation :

Membres inférieurs le plus souvent

- Formes **cervico-faciales**, plutôt après chirurgie **ORL**.
- Formes **thoraco-abdominales** : après chirurgie **thoracique ou digestive**.
- Formes **périnéales** (gangrène de Fournier) : chirurgie ou procédure **digestive ou urologique**.

4/ les facteurs favorisants :

- Les dermohypodermes bactériennes nécrosantes surviennent le plus souvent chez les malades atteints:
 - **Hémopathies, des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires,**
 - **Chez les immunodéprimés, les alcooliques et les toxicomanes.**
- La prise d'AINS** pourrait être un facteur **favorisant ou aggravant** du développement de cette complication.

Physiopathologie

- Cette infection provoque **une nécrose de l'hypoderme avec thrombose vasculaire, une nécrose de l'aponévrose superficielle** sous jacente (ce qui définit la fasciite) et secondairement, **la nécrose du derme.**

C. Diagnostic positif

-La présentation initiale est celle d'un érysipèle, mais certains signes doivent faire suspecter une forme nécrosante :

***Signes de sepsis grave.**

***Douleur intense**, non soulagée par des antalgiques de palier 1 ou 2, s'étendant au-delà des zones inflammatoires

***Induration des tissus** au-delà des lésions visibles (difficile à percevoir si terrain de lymphoedème).

-**La nécrose cutanée** est un signe capital, souvent limitée à quelques **taches cyaniques , froides, hypoesthésique.**

Parfois, elle est évidente en cas de placards nécrotiques bien limités, en carte de géographie.

-**Une crépitation neigeuse** est présente en cas d'infection associée par un anaérobie.

- Les éléments d'un syndrome septique grave sont présents à des degrés divers : **état confusionnel, hypotension artérielle, oligurie, hypothermie, hypoxémie thrombopénie.**









Figure 3. Fasciite nécrosante du membre inférieur gauche avec zones nécrotiques et bulles.

**Examens paracliniques

→ Le diagnostic est clinique.

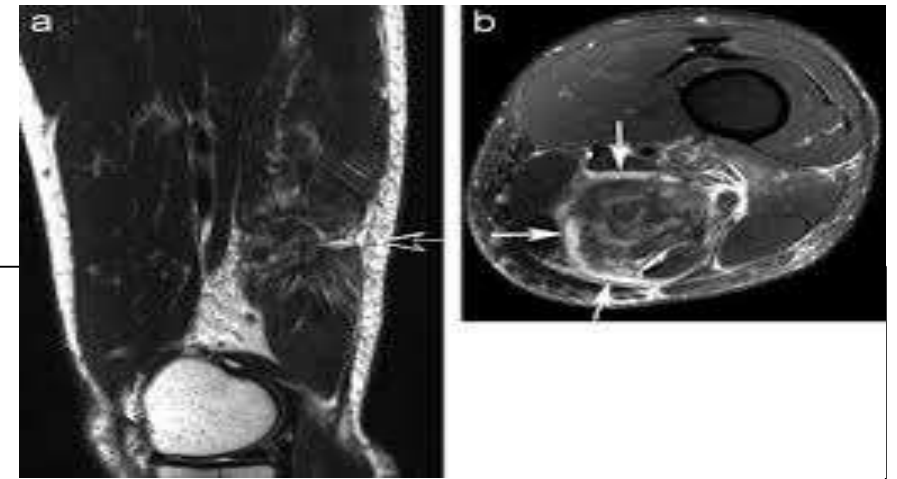
*L'imagerie par un radiologue expérimenté (**tomodensitométrie ou IRM surtout**, échographique rarement) peut montrer des anomalies de densité ou de signal de la graisse sous-cutanée, de l'aponévrose superficielle et des muscles, mais la mise en évidence d'abcès ou de collection est exceptionnelle.

- La réalisation de ces examens ne doit pas **retarder le geste chirurgical**.

→ examens microbiologiques

***Les prélèvements locaux** (porte d'entrée, per opératoires) ainsi que les hémocultures permettent l'isolement des bactéries responsables.

*Le **streptocoque bêta hémolytique de groupe A** (*S.pyogenes*) est fréquemment isolé.



La Gangrène de Fournier est une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante et fasciite nécrosante (DHBN-FN) grave des régions périnéales.

-Elle est **rare** et peut se voir quelque soit l'âge.

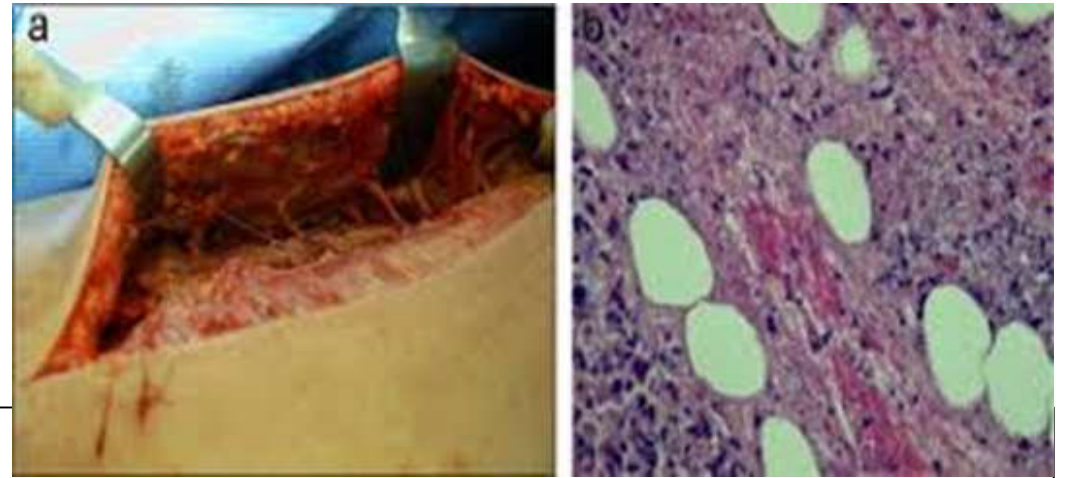
-La flore **microbienne est mixte** et variée en rapport avec une porte d'entrée particulière.

-Dans 80% des cas environ, la survenue d'une gangrène de Fournier est favorisée par des **causes loco-régionales** telles que **les infections urinaires, les sténoses urétrales, les infections périanales ou les infections dermatologiques périnéales.**

-D'autres facteurs de risque « généraux » sont également bien connus tels que le **diabète** (facteur de risque majeur de gangrène des organes génitaux externes), **ou l'immunodépression**

D. Traitement :

- Les dermohypodermes sont une **urgence médicochirurgicale** car le pronostic vital est en jeu.
- Le malade doit être admis en **réanimation** pour instaurer sans délai:
 1. Le **traitement symptomatique de l'état septique** :Réanimation, prise en charge des défaillances d'organe(s) et prise en charge des comorbidités
 2. Un TRT **chirurgical**
 3. Une **antibiothérapie appropriée par voie parentérale**: adaptation aux prélèvements peropératoires
 4. Prévention **antitétanique si nécessaire**



Traitement chirurgicale

- Débridement chirurgical large** de l'ensemble des tissus nécrosés, avec reprise si besoin à plusieurs reprises les jours suivants tant que réapparaissent des zones de nécrose.
- Dans un second temps, si nécessaire, **chirurgie reconstructrice** (lambeaux, greffes...).
- Traitement de la porte d'entrée**
- Amputation** parfois nécessaire.
- Dérivation digestive** (colostomie de décharge) et/ou urinaire dans les formes périnéales.

-Traitement antibiotique

-Le traitement antibiotique est **habituellement probabiliste** et tient compte de la **localisation anatomique** et donc des bactéries potentiellement prédominantes.

-Dans les localisations aux **membres ou cervico-faciales** (prédominance **des streptocoque et anaérobie**) :
association β -lactamine + inhibiteur de β -lactamase (amoxicilline + acide clavulanique) + **clindamycine**
(effet anti-toxinique, diffusion)

-Dans les localisation **de l'abdomen et de périnée** prédominance des **anaérobies et des entérobactéries**. on choisira association **de β -lactamine** à large spectre (**pipéracilline + tazobactam, ou imipenème**) + **métronidazole** (pour son action anti-Clostridium) associe a un **aminoside**.

-**Toxicomane** : la fréquente implication d'un staphylocoque dore justifie une association dirigée contre cette bactérie mais gardant une action efficace contre le streptocoque : **amoxicilline + acide clavulanique**, ou **pénicilline M** , $\pm$ **couverture anti-SARM** (vancomycine par exemple) + **aminoside**.